

Conjuntivitis (bacteriana, viral, alérgica)

1. Introducción y relevancia clínica

La **conjuntivitis** es la inflamación de la **conjuntiva**, membrana mucosa que recubre la superficie interna de los párpados y la esclerótica.

Es la **causa más frecuente de ojo rojo en atención primaria**, y aunque raramente amenaza la visión, su reconocimiento es fundamental para **distinguir causas benignas de aquellas que requieren derivación urgente**, como queratitis, uveítis o glaucoma.

Importancia clínica:

- Constituye hasta el **50% de las consultas oftalmológicas** en APS.
 - En Chile, su abordaje está normado por la **Guía Clínica MINSAL de Infecciones Oculares (2018)**.
 - Puede ser **infecciosa (bacteriana o viral)** o **no infecciosa (alérgica, irritativa, autoinmune)**.
 - El diagnóstico es principalmente **clínico**, pero el **error diagnóstico** con cuadros graves (como queratitis herpética o uveítis anterior) es un **error común en EUNACOM**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Estructura y función de la conjuntiva

La conjuntiva cumple funciones de **protección inmunológica y lubricación**.

Contiene:

- **Células caliciformes:** secretan mucina para mantener el film lagrimal.
 - **Folículos linfáticos y vasos sanguíneos** que facilitan respuesta inflamatoria.
 - **Glándulas accesorias lagrimales**, que contribuyen a la capa acuosa.
-

2.2 Fisiopatología de los distintos tipos de conjuntivitis

A. Conjuntivitis bacteriana

- Infección de la conjuntiva por bacterias patógenas o flora comensal oportunista.
- Los agentes más comunes:
 - *Staphylococcus aureus* (adultos)
 - *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* (niños)
 - *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis* (ETS o neonatal)
- La inflamación genera vasodilatación, secreción purulenta y adherencia palpebral.

B. Conjuntivitis viral

- Predominantemente causada por **adenovirus** (serotipos 3, 7, 8, 19).
- Altamente contagiosa, con transmisión por contacto directo o fómites.
- Se asocia a cuadros respiratorios previos.
- Puede acompañarse de queratitis subepitelial.

C. Conjuntivitis alérgica

- Hipersensibilidad tipo I mediada por IgE tras exposición a alérgenos ambientales (pólenes, polvo, ácaros).
- Produce liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos → prurito, edema y lagrimeo.
- Formas graves: **queratoconjuntivitis vernal (infantil)** y **atópica** (adultos jóvenes).

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas comunes

- Ojo rojo bilateral o unilateral.

- Lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, picazón o ardor.
- Secreción variable (acuosa, mucosa o purulenta).
- Fotofobia leve en casos con queratitis asociada.

3.2 Características clínicas distintivas

Característica	Bacteriana	Viral	Alérgica
Inicio	Agudo, horas a 1 día	Subagudo, 2–3 días	Estacional o recurrente
Lateralidad	Habitualmente bilateral, puede comenzar unilateral	Unilateral que progresa a bilateral	Bilateral simultáneo
Secreción	Purulenta, amarillenta, espesa	Serosa, acuosa	Mucosa, acuosa, hilos
Adherencia palpebral matutina	Frecuente	Leve o ausente	Ausente
Prurito	Ausente	Leve	Intenso
Adenopatía preauricular	Rara	Común	Ausente
Otros hallazgos	Pus visible, conjuntiva hiperémica difusa	Folículos, pseudomembranas	Papilas en conjuntiva tarsal, quemosis

3.3 Diagnóstico diferencial (ojo rojo no conjuntivitis)

Patología	Claves diferenciales
Uveítis anterior	Dolor profundo, fotofobia, miosis, visión borrosa
Queratitis	Dolor, fotofobia, opacidad corneal o tinción con fluoresceína positiva
Glaucoma agudo	Dolor severo, visión borrosa, halos de colores, midriasis fija
Epiescleritis / Escleritis	Dolor localizado, vasos profundos, no secreción

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de conjuntivitis es **clínico** en la mayoría de los casos.

4.1 Exámenes indicados solo en casos especiales

- **Tinción con fluoresceína:** descarta úlcera corneal o cuerpo extraño.
- **Cultivo y antibiograma:** en secreciones purulentas persistentes (>1 semana), inmunosupresión o sospecha gonocócica/clamidal.
- **Test de Schirmer o IgE sérica:** si se sospecha componente alérgico crónico.
- **PCR o inmunofluorescencia:** en conjuntivitis neonatal o ETS.

4.2 Criterios diagnósticos clínicos

- **Conjuntivitis bacteriana:** hiperemia difusa, secreción purulenta, adherencia palpebral, sin dolor ni fotofobia.
- **Conjuntivitis viral:** folículos, secreción acuosa, adenopatía preauricular, antecedente respiratorio.

- **Conjuntivitis alérgica:** prurito intenso, quemosis, papilas, bilateralidad.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Medidas generales

- **Higiene ocular:** limpieza con suero fisiológico o agua hervida enfriada varias veces al día.
 - **Evitar frotarse los ojos.**
 - **Suspender lentes de contacto** hasta resolución.
 - **No usar colirios corticoides** sin indicación médica.
 - Lavado de manos y no compartir toallas (casos virales).
-

5.2 Tratamiento específico

A. Conjuntivitis bacteriana

- La mayoría se resuelve espontáneamente en 5–7 días, pero los antibióticos acortan la evolución.
 - **Antibióticos tópicos:**
 - Eritromicina 0,5% ungüento cada 6–8 h por 7 días.
 - Cloranfenicol 0,5% gotas cada 6 h (uso extendido en Chile).
 - Alternativa: ciprofloxacino 0,3% cada 6 h (lentes de contacto o pseudomonas).
 - **No se recomienda antibiótico sistémico** salvo en casos de gonococia o clamidia:
 - *N. gonorrhoeae*: ceftriaxona 1 g IM dosis única.
 - *C. trachomatis*: doxiciclina 100 mg VO c/12 h × 7 días.
-

B. Conjuntivitis viral

- **Tratamiento sintomático:**
 - Lágrimas artificiales sin conservantes.
 - Compresas frías.
 - Analgésicos orales si hay molestia.
 - **Evitar antibióticos tópicos innecesarios.**
 - **Prevención:** aislamiento relativo, evitar contacto directo y compartir objetos personales.
 - **Corticoides tópicos:** solo en casos graves con queratitis subepitelial y siempre bajo indicación oftalmológica.
-

C. Conjuntivitis alérgica

- **Evitar alérgeno identificado.**
 - **Lágrimas artificiales frías y compresas frías.**
 - **Antihistamínicos tópicos:**
 - Olopatadina 0,1% cada 12 h o ketotifeno 0,025% cada 12 h.
 - **Estabilizadores de mastocitos:** cromoglicato o nedocromil en cuadros recurrentes.
 - **Antihistamínicos orales:** loratadina, cetirizina.
 - **Corticoides tópicos:** solo bajo supervisión especializada si hay queratoconjuntivitis vernal o severa.
-

5.3 Derivación a oftalmología

Derivar urgente o preferente si:

- Dolor ocular o fotofobia intensa.
- Disminución de agudeza visual.

- Sospecha de úlcera o queratitis herpética.
- Secreción purulenta profusa o persistente >10 días.
- Sospecha de etiología gonocócica, clamidial o neonatal.
- Recaídas frecuentes sin causa evidente.

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Complicaciones	Pronóstico
Bacteriana	Queratitis secundaria, celulitis preseptal, cicatrices conjuntivales	Excelente con tratamiento
Viral	Queratitis subepitelial, pseudomembranas, conjuntivitis hemorrágica	Autolimitado (1–3 semanas)
Alérgica	Queratitis vernal, úlceras corneales por rascado	Crónico, controlable

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Prurito = alérgica; secreción purulenta = bacteriana; adenopatía preauricular = viral.**
2. En **adenovirus**, la conjuntivitis es muy contagiosa: aislamiento 10–14 días.
3. **No usar colirios con corticoides** en infecciones herpéticas o sin diagnóstico confirmado.
4. Si el paciente **usa lentes de contacto**, cubrir siempre *Pseudomonas* con ciprofloxacino.

5. En **neonatos**, siempre descartar gonococia o clamidia y tratar con antibióticos sistémicos.
 6. **El tratamiento con antibióticos tópicos** acelera la resolución en bacteriana, pero es innecesario en viral o alérgica.
 7. **Conjuntivitis con dolor intenso y fotofobia** debe hacer sospechar **queratitis o uveítis** (no conjuntivitis simple).
-

Errores comunes

- Diagnosticar todas las conjuntivitis como “bacterianas” y prescribir antibióticos de rutina.
 - No indagar el **uso de lentes de contacto** (riesgo de Pseudomonas).
 - Usar **corticoides tópicos empíricos**.
 - No examinar la córnea con fluoresceína.
 - No educar sobre **medidas higiénicas** en casos virales.
 - Ignorar **síntomas sistémicos** (ETS, infección respiratoria).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **conjuntivitis** es la causa más frecuente de ojo rojo; se clasifica en **bacteriana, viral y alérgica**.
2. **Prurito = alérgica; secreción purulenta = bacteriana; adenopatía preauricular = viral**.
3. La **mayoría de las bacterianas son autolimitadas**, pero responden más rápido a antibióticos tópicos.
4. **Viral**: manejo sintomático y aislamiento; evitar antibióticos y corticoides.
5. **Alérgica**: uso de antihistamínicos tópicos y control ambiental.
6. **Lentes de contacto** → **sospechar Pseudomonas** y usar ciprofloxacino tópico.

7. Derivar toda conjuntivitis con **dolor, fotofobia o disminución visual**, pues puede ocultar una queratitis o uveítis.